

Mandatsnotiz

Möllenkamp & Feldhaus Rechtsanwälte Windthorststraße 16, 48143 Münster Telefon 0251 48 20 63-0
Bearbeiter: Rechtsanwalt Dr. Jonas Möllenkamp, Fachanwalt für Sozialrecht und Fachanwalt für
Medizinrecht Aktenzeichen intern: 2026-233-LÜ/mö Erstkontakt: 28.06.2026, telefonisch durch die
Ehefrau; Besprechungstermin am 29.06.2026 in der Wohnung des Mandanten

Mandant

Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, gelernter Elektrotechniker, wohnhaft Zum Häpper 9, 48165
Münster-Hiltrup. Verheiratet mit Teresa Lütke, die den Kontakt hergestellt hat. Krankenversicherung:
Vitalis BKK, Versichertennummer V-338-529-114. Der Mandant ist seit Mai 2026 arbeitsunfähig, hat starke
Schmerzen im Becken und multiple Lungenmetastasen.

Medizinischer Hintergrund

Diagnose: metastasiertes alveoläres Weichteilsarkom, Erstdiagnose 2022, Operation und
Strahlentherapie 2022, systemische Standardtherapien 2023 bis 2026, Progress im März 2026. Die
Universitätsklinik Münster sieht keine kurative Option mehr. Behandlungsziel ist die Verlängerung des
progressionsfreien Überlebens, Schmerzreduktion und der Erhalt der Selbstständigkeit.

Beantragtes Arzneimittel: Lunazimerab, monoklonaler Antikörper, zugelassen als Arzneimittel für seltene
Leiden (Orphan Drug), aber nicht für die Tumorentität des Mandanten. Dosierung nach Klinikplan: drei
Dosen im Abstand von sechs Wochen. Kosten je Dosis laut Apothekenkalkulation: rund 500.000 EUR
zuzüglich Zubereitung und Überwachung.

Verfahrensstand

Antrag der Klinik vom 04.06.2026. MD-Stellungnahme vom 17.06.2026. Ablehnungsbescheid der Vitalis
BKK vom 21.06.2026, Zugang am 24.06.2026; Widerspruchsfrist notiert auf den 24.07.2026. Widerspruch
noch nicht eingelegt. Die Klinik reserviert einen Therapieslot für den 11.07.2026, fordert aber vorher eine
belastbare Kostenklärung; der Hersteller hält die erste Dosis nur bis zum 05.07.2026 vor.

Erste Einschätzung für die Handakte

1. Der Mandant ist schwer krank, aber nicht unmittelbar moribund; die Eilbedürftigkeit muss über das konkrete Therapiefenster und den drohenden Verlust der Behandlungschance begründet werden.
2. Die Kosten sind außergewöhnlich hoch; das Wirtschaftlichkeitsargument der Kasse ist ernst zu nehmen und nur über die fehlende Alternative zu entkräften.
3. Die Nutzenlage ist nicht leer, aber unsicher (Phase-II-Daten, Registerdaten, molekulare Zielstruktur LZ-4); keine randomisierte Phase-III-Studie.
4. Der MD stellt auf fehlende vergleichende Evidenz ab und hat den Mandanten nicht untersucht.
5. Das Gericht wird im Eilverfahren medizinische Plausibilität und Folgenabwägung verbinden müssen; ein gestuftes Vorgehen (erste Dosis mit Monitoring) als Vergleichslinie vorbereiten.

Auftrag

1. Widerspruch sofort einlegen.

2. Eilantrag zum Sozialgericht vorbereiten.
3. Ärztliche Zusatzstellungnahme zu lebensbedrohlicher Erkrankung, fehlender Alternative und Nutzenwahrscheinlichkeit anfordern.
4. Die Kassenargumente Evidenz, Wirtschaftlichkeit und fehlende G-BA-Bewertung gezielt bearbeiten.

Antrag der Universitätsklinik Münster

Universitätsklinikum Münster Klinik für Hämatologie und Onkologie, Sarkomzentrum
Albert-Schweitzer-Campus 1, 48149 Münster Telefon 0251 83-4 77 51

Prof. Dr. med. Mira Ebbinghaus, Oberärztin Sarkomzentrum

Münster, den 04.06.2026

An die Vitalis BKK Leistungszentrum Arzneimittel Rheinlanddamm 199 44139 Dortmund

Antrag auf Kostenübernahme für Lunazimerab; Versicherter Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, Versichertennummer V-338-529-114

Antrag auf Kostenübernahme

Für unseren Patienten Gregor Lütke beantragen wir die Kostenübernahme für eine Therapie mit Lunazimerab. Es handelt sich um ein Arzneimittel mit Zulassung für eine seltene Tumorentität. Der Patient leidet an einem metastasierten alveolären Weichteilsarkom mit Progress nach zwei systemischen Vorthérapien.

Bisheriger Verlauf

Datum	Maßnahme	Ergebnis
03.02.2022	Tumorresektion linker Oberschenkel	R1-Situation, Nachbestrahlung
04.2022 bis 06.2022	Strahlentherapie	lokale Kontrolle
08.2023	Lungenmetastasen	systemische Therapie begonnen
09.2023 bis 02.2025	Standardtherapie A	zunächst Stabilisierung, dann Progress
03.2025 bis 03.2026	Standardtherapie B	Progress in Lunge und Becken
29.05.2026	Tumorboard	Empfehlung Lunazimerab

Ärztliche Bewertung

Aus onkologischer Sicht besteht eine lebensbedrohliche Erkrankung mit kurzfristig relevanter Progressionsgefahr. Weitere leitliniengerechte Standardoptionen mit vergleichbarer Erfolgsaussicht stehen nicht zur Verfügung. Best Supportive Care ist möglich, würde aber voraussichtlich nur Symptomkontrolle, nicht Krankheitskontrolle erreichen.

Die vorliegenden Daten zu Lunazimerab zeigen bei einer Teilgruppe der Patienten mit vergleichbarer molekularer Signatur relevante Remissionen und eine Verlängerung des progressionsfreien Überlebens. Beim Patienten liegt die Zielstruktur LZ-4 nach immunhistochemischer Untersuchung hoch exprimiert vor.

Wir bitten wegen des geplanten Therapiebeginns am 11.07.2026 um Entscheidung bis zum 05.07.2026; der Hersteller reserviert die erste Dosis nur bis zu diesem Tag. Den Kostenvoranschlag unserer Klinikapotheke reichen wir nach, sobald er vorliegt.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. med. Mira Ebbinghaus Oberärztin Sarkomzentrum

Tumorboard und Nutzenblatt

Universitätsklinikum Münster, Sarkomzentrum Auszug aus der Behandlungsdokumentation, der Kanzlei übergeben am 29.06.2026

Protokoll Sarkom-Tumorboard vom 29.05.2026

Vorsitz: Prof. Dr. Ebbinghaus. Anwesend: Onkologie, Radiologie, Pathologie, Strahlentherapie, Palliativmedizin, Studienkoordination, Psychoonkologie.

Fall: Gregor Lütke, 46 Jahre, metastasiertes alveoläres Weichteilsarkom. ECOG 1 bis 2, hohe Motivation, familiär eingebunden. Bildgebung vom 24.05.2026 zeigt Progress der pulmonalen Herde und neue osteolytische Läsion im rechten Os ilium. Schmerzen aktuell mit Oxycodon retard 2 mal 20 mg kontrolliert.

Diskutierte Optionen

Option	Nutzen	Einwand
Best Supportive Care	Symptomkontrolle, geringe Toxizität	keine Krankheitskontrolle
Re-Challenge Standardtherapie A	ambulant verfügbar	Progress unter gleicher Substanz dokumentiert
Phase-I-Studie Hamburg	wissenschaftlich interessant	Einschluss frühestens September, Reisefähigkeit fraglich
Lunazimerab	zielgerichtete Therapie, Orphan-Drug-Zulassung	extrem hohe Kosten, begrenzte Daten

Ergebnis

Das Tumorboard empfiehlt Lunazimerab. Die Empfehlung beruht auf fehlenden Standardalternativen, Zielstruktur LZ-4, gutem Allgemeinzustand und realistischer Aussicht auf klinisch relevante Krankheitskontrolle. Palliativmedizin soll parallel eingebunden bleiben.

Nutzenblatt für die Kasse

Die Klinik schätzt die realistische Nutzenerwartung nicht als Heilung, sondern als Verlängerung der krankheitskontrollierten Zeit um etwa 18 bis 24 Monate bei Ansprechen. Die Aussage beruht auf der Studie LUNA-SAR-02 (einarmige Phase-II-Studie, 41 Patienten, davon 12 mit hoher LZ-4-Expression), Registerdaten aus Frankreich und dem molekularen Befund des Patienten. Die Klinik räumt ein, dass es keine randomisierte Phase-III-Studie gibt und nach der Seltenheit der Erkrankung voraussichtlich auch nicht geben wird.

Stellungnahme des Medizinischen Dienstes

Medizinischer Dienst Westfalen-Lippe Gutachtenzentrum Münster Roddestraße 12, 48153 Münster

Gutachter: Dr. med. Peter Niermann, Facharzt für Innere Medizin, Sozialmedizin Vorgangsnummer: MD-WL-MS-2026-58207 Gutachtliche Stellungnahme nach Aktenlage vom 17.06.2026

Auftrag

Auftrag der Vitalis BKK vom 09.06.2026: Prüfung der beantragten Kostenübernahme für Lunazimerab bei metastasiertem alveolärem Weichteilsarkom; Versicherter Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979.

Vorliegende Unterlagen

Antrag der Universitätsklinik Münster vom 04.06.2026 mit Verlaufstabelle, Tumorboardprotokoll vom 29.05.2026, Nutzenblatt der Klinik, immunhistochemischer Befund zur Zielstruktur LZ-4, Publikationsliste zur Studie LUNA-SAR-02. Eine persönliche Untersuchung des Versicherten fand nicht statt.

Zusammenfassung

Beim Versicherten liegt eine schwerwiegende onkologische Erkrankung vor. Die bisherigen leitliniengerechten Therapien sind ausgeschöpft. Gleichwohl kann die beantragte Arzneimitteltherapie aus sozialmedizinischer Sicht nicht empfohlen werden.

Begründung

Die vorgelegten Unterlagen belegen eine Orphan-Drug-Zulassung für eine andere Tumorentität, aber keine abgeschlossene Nutzenbewertung mit tragfähiger Aussage zur zweckmäßigen Vergleichstherapie für die hier vorliegende Erkrankung. Die Klinik verweist auf Phase-II-Daten und Registerdaten. Diese Daten sind hypothesengenerierend und erlauben keine belastbare Aussage, dass beim Versicherten eine Verlängerung der krankheitskontrollierten Zeit um 18 bis 24 Monate zu erwarten ist. Die Subgruppe mit hoher LZ-4-Expression umfasst in der Studie zwölf Patienten.

Best Supportive Care ist möglich; eine Studienteilnahme (Phase-I-Studie in Hamburg, Einschluss nach den Unterlagen frühestens im September) ist nicht ausgeschlossen. Die Kosten von etwa 500.000 EUR je Dosis stehen in einem besonders auffälligen Verhältnis zur unsicheren Nutzenlage. Eine Leistungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung kann aus den vorgelegten Unterlagen nicht abgeleitet werden.

Empfehlung

Ablehnung der Kostenübernahme. Es sollte eine erneute Vorstellung in einer Studienambulanz geprüft werden. Eine palliativmedizinische Mitbehandlung wird empfohlen. Bei wesentlich veränderter Studienlage wird um erneute Vorlage gebeten.

gez. Dr. Niermann

Ablehnungsbescheid der Vitalis BKK

Vitalis BKK Leistungszentrum Arzneimittel Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund Servicetelefon 0231 91 44 7-0

Aktenzeichen: LZ-AM-2026-07731 Versichertennummer: V-338-529-114

Dortmund, den 21.06.2026

Herrn Gregor Lütke Zum Häpper 9 48165 Münster

Ihr Antrag auf Kostenübernahme für das Arzneimittel Lunazimerab (Antrag der Universitätsklinik Münster vom 04.06.2026)

Sehr geehrter Herr Lütke,

die Kostenübernahme für das Arzneimittel Lunazimerab lehnen wir ab.

Begründung

Die beantragte Therapie ist außergewöhnlich kostenintensiv. Nach der Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 17.06.2026, die wir Ihnen in Kopie beifügen, liegt keine hinreichend gesicherte Datenlage vor, die einen individuellen Nutzen in dem von der Klinik angenommenen Umfang belegt. Die vorhandenen Studien sind nicht vergleichend angelegt. Eine Behandlung im Sinne von Best Supportive Care und die Prüfung einer Studienteilnahme stehen Ihnen weiterhin offen.

Die gesetzliche Krankenversicherung darf nur Leistungen erbringen, die ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sind. Bei ungesicherter Nutzenlage und Kosten von etwa 1.500.000 EUR für drei Dosen ist die beantragte Versorgung nicht wirtschaftlich.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Vitalis BKK, Leistungszentrum Arzneimittel, Rheinlanddamm 199, 44139 Dortmund, einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Vitalis BKK Leistungszentrum Arzneimittel

Aktenvermerk der Kanzlei: Telefonnotiz zur Ehefrau

Zugang des Bescheids nach Angaben des Mandanten am 24.06.2026. Frau Teresa Lütke rief am 25.06.2026 bei der Kasse an. Eine Sachbearbeiterin sagte nach ihrer Erinnerung: "Bei solchen Summen entscheidet am Ende sowieso das Gericht." Ein schriftliches Gesprächsprotokoll der Kasse liegt nicht vor; Frau Lütke hat sich den Satz noch am selben Tag notiert.

Widerspruch und Eilantrag

Widerspruch an die Vitalis BKK

Möllenkamp & Feldhaus Rechtsanwälte Windthorststraße 16, 48143 Münster Telefon 0251 48 20 63-0
Rechtsanwalt Dr. Jonas Möllenkamp, Fachanwalt für Sozialrecht und Fachanwalt für Medizinrecht

An die Vitalis BKK Leistungszentrum Arzneimittel Rheinlanddamm 199 44139 Dortmund

vorab per Telefax

Münster, den 29.06.2026 Unser Zeichen: 2026-233-LÜ/mö Ihr Aktenzeichen: LZ-AM-2026-07731

In Sachen Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, Versichertennummer V-338-529-114

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die Vertretung von Herrn Gregor Lütke an; Vollmacht liegt bei. Namens und in Vollmacht unseres Mandanten legen wir gegen Ihren Bescheid vom 21.06.2026, zugegangen am 24.06.2026, **Widerspruch** ein.

Die Ablehnung würdigt die konkrete medizinische Situation nicht ausreichend. Unser Mandant leidet an einer lebensbedrohlichen, seltenen Tumorerkrankung. Die leitliniengerechten Standardtherapien sind ausgeschöpft; das ergibt sich aus dem Antrag der Universitätsklinik und wird auch vom Medizinischen Dienst nicht in Zweifel gezogen. Die behandelnde Universitätsklinik hat mit der hohen LZ-4-Expression eine individuelle Zielstruktur nachgewiesen und die Therapie im interdisziplinären Tumorboard empfohlen.

Die Stellungnahme des Medizinischen Dienstes vom 17.06.2026 beruht allein auf der Aktenlage. Sie setzt sich mit dem molekularen Befund nicht auseinander, bewertet die tatsächliche Reisefähigkeit unseres Mandanten für die als Alternative genannte Studie in Hamburg nicht und verhält sich nicht zu dem konkreten Zeitfenster des auf den 11.07.2026 reservierten Therapiebeginns. Der Verweis auf Best Supportive Care bleibt abstrakt: Es wird nicht dargelegt, welche Lebenszeit und Lebensqualität damit realistischerweise erreichbar wären. Eine persönliche Begutachtung hat nicht stattgefunden.

Wir beantragen, den Bescheid vom 21.06.2026 aufzuheben und die Versorgung mit Lunazimerab nach dem Behandlungsplan der Universitätsklinik Münster zu bewilligen, hilfsweise unverzüglich eine persönliche fachonkologische Begutachtung zu veranlassen. Angesichts des Therapiefensters bitten wir um Entscheidung bis zum 03.07.2026; danach werden wir einstweiligen Rechtsschutz in Anspruch nehmen.

Dr. Jonas Möllenkamp Rechtsanwalt

Entwurf Eilantrag Sozialgericht Münster

Entwurf vom 30.06.2026, Az. 2026-233-LÜ/mö — Einreichung per beA, sobald die Kasse nicht bis zum 03.07.2026 abhilft

Antrag:

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, dem Antragsteller vorläufig die Versorgung mit Lunazimerab nach ärztlicher Verordnung der Universitätsklinik Münster für zunächst drei Dosen zu gewähren.

Hilfsweise wird beantragt, die Antragsgegnerin zu verpflichten, binnen 48 Stunden eine persönliche fachonkologische Begutachtung unter Einbeziehung des Tumorboards zu veranlassen und bis dahin die Therapiereservierung nicht durch Untätigkeit vereiteln zu lassen.

Anordnungsgrund

Der Therapieslot ist auf den 11.07.2026 reserviert; der Hersteller hält die erste Dosis nur bis zum 05.07.2026 vor, danach ist eine neue Freigabe mit Lieferzeit erforderlich. Nach Auskunft der Klinik verschlechtert jede weitere Verzögerung die Chance auf Krankheitskontrolle; die Bildgebung vom 10.06.2026 zeigt eine zunehmende Belastung der rechten Lunge und eine neue Läsion am Beckenkamm. Eine Entscheidung in der Hauptsache käme für den Antragsteller voraussichtlich zu spät. Die Eheleute Lütke können Kosten von rund 500.000 EUR je Dosis offensichtlich nicht vorfinanzieren.

Beweisangebote

1. Ärztliche Stellungnahme Prof. Dr. Ebbinghaus.
2. Tumorboardprotokoll vom 29.05.2026.
3. Molekularpathologischer Befund LZ-4.
4. Kostenvoranschlag der Krankenhausapotheke vom 21.06.2026.
5. Anhörung der behandelnden Onkologin.
6. Hilfsweise gerichtliches Sachverständigengutachten mit Fristsetzung.

Gerichtliche Beweisfragen und Vergleichsfenster

Arbeitspapier der Kanzlei, Az. 2026-233-LÜ/mö, Stand 30.06.2026: Antizipation des zu erwartenden gerichtlichen Vorgehens im Eilverfahren, zur Vorbereitung der Klinik-Stellungnahme und einer Vergleichslinie.

Zu erwartender richterlicher Hinweis

Das Gericht beabsichtigt, kurzfristig eine ergänzende Stellungnahme der Universitätsklinik Münster einzuholen. Die Beteiligten werden darauf hingewiesen, dass im Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes nicht die vollständige Hauptsache vorweggenommen werden soll, jedoch der drohende Verlust einer realistischen Behandlungschance zu berücksichtigen sein kann.

Beweisfragen an die Klinik

1. Welche Standardtherapien sind beim Antragsteller ausgeschöpft und aus welchem Grund?
2. Welche konkrete Zielstruktur begründet die Auswahl von Lunazimerab?
3. Welche Daten tragen die Erwartung einer klinisch relevanten Krankheitskontrolle?
4. Welche Folgen hat eine Verzögerung des Therapiebeginns um vier, acht oder zwölf Wochen?
5. Welche objektiven Abbruchkriterien können nach der ersten oder zweiten Dosis festgelegt werden?

Vergleichsfenster

Eine Vergleichslösung könnte eine erste Dosis mit engmaschigem Monitoring und erneuter Entscheidung über Dosis zwei und drei vorsehen. Die Kasse würde damit keine unbefristete Kostenzusage erteilen, der Versicherte verlöre aber nicht das aktuelle Behandlungsfenster. Streitpunkt bleibt, ob eine solche Aufteilung medizinisch sinnvoll und rechtlich zulässig ist.

Kostenvoranschlag der Krankenhausapotheke

Universitätsklinikum Münster Apotheke und Arzneimittelherstellung Albert-Schweitzer-Campus 1,
Gebäude A12, 48149 Münster Telefon 0251 83-4 80 20

Vorgang: Gregor Lütke, geboren am 22.11.1979, Fallnummer UKM-2026-448 517 Erstellt am: 21.06.2026,
auf Anforderung des Sarkomzentrums (Prof. Dr. Ebbinghaus)

Arzneimittel

Lunazimerab 500 mg Infusionskonzentrat, Sonderbeschaffung über Herstellerprogramm "LZM-Access EU". Das Arzneimittel ist für die beantragte Indikation nicht als Standardtherapie im deutschen Versorgungspfad hinterlegt. Die Klinik sieht nach Tumorboardbeschluss dennoch ein enges Zeitfenster, weil der Patient nach der letzten Bildgebung vom 10.06.2026 eine deutliche Progression in Lunge und Becken zeigt.

Kosten

Position	Menge	Einzelbetrag	Gesamt
Wirkstoff Lunazimerab 500 mg	1 Dosis	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
Einfuhr, Kühlkette, Sicherheitslogistik	1 Vorgang	8.920,00 EUR	8.920,00 EUR
Sterile Aufbereitung und Plausibilitätsprüfung	1 Vorgang	1.480,00 EUR	1.480,00 EUR
Begleitmedikation und Notfallset	1 Gabe	1.265,00 EUR	1.265,00 EUR
Summe erste Gabe			511.665,00 EUR

Für den beantragten Behandlungszyklus sind drei Gaben im Abstand von jeweils sechs Wochen vorgesehen (geplant 11.07.2026, 22.08.2026 und 03.10.2026). Die Apotheke kalkuliert für drei Gaben einschließlich Logistik und Aufbereitung 1.534.995,00 EUR.

Liefer- und Verfallsrisiko

Der Hersteller reserviert die erste Dosis bis 05.07.2026. Danach ist eine neue Freigabe erforderlich. Eine angebrochene Dosis kann nicht weiterverwendet werden. Die Lieferung muss 72 Stunden vor Applikation beauftragt sein. Eine Finanzierung nachträglich nach Gabe ist aus Sicht der Apotheke nur möglich, wenn vorher eine Kostenzusage, ein gerichtlicher Beschluss oder eine schriftliche Übernahmeerklärung vorliegt.

Fachliche Rückfrage der Apotheke

Die Apotheke bittet die behandelnde Klinik um schriftliche Bestätigung, ob die erste Gabe ambulant in der Tagesklinik oder stationär erfolgen soll. Bei stationärer Gabe sind gesonderte DRG- und NUB-Fragen zu klären. Bei ambulanter Gabe liegt das Kostenrisiko unmittelbar bei der beantragten Einzelkostenübernahme.

Pflege- und Schmerzprotokoll

Gregor Lütke

geführt von: Teresa Lütke, Ehefrau

Zeitraum: 17.06.2026 bis 23.06.2026

17.06.2026

Morgens Atemnot nach Treppe vom Schlafzimmer ins Erdgeschoss. Pause auf der siebten Stufe. Schmerz rechte Hüfte 6 von 10. Novalgin genommen. Spaziergang zur Ecke nach 80 Metern abgebrochen.

18.06.2026

Nachts zweimal aufgewacht wegen Druck im Brustkorb. Kein Fieber. Appetit gering. Telefonat mit Klinik: Bitte Schmerzprotokoll weiterführen. Gregor sagt, er wolle die Entscheidung der Kasse nicht "aussitzen", weil er merkt, dass die Luft schlechter wird.

19.06.2026

Hausarzt Dr. Kannenberg daheim. Sauerstoffsättigung nach Gang durch Flur 91 Prozent, in Ruhe 95 Prozent. Oxycodon niedrig dosiert besprochen, Gregor zögert wegen Müdigkeit. Arzt sagt, Therapiefenster solle nicht ohne medizinischen Grund verstreichen.

20.06.2026

Besuch der Schwester. Gregor konnte 35 Minuten am Tisch sitzen, danach Liegen. Schmerz Becken 7 von 10. Einmal Übelkeit. Keine Einweisung, weil Termin in Münster erwartet wird.

21.06.2026

Vormittags besser. 120 Meter bis zum Parkplatz geschafft, aber Rückweg mit zwei Pausen. Abends wieder Atemnot. Gregor fragt nach Patientenverfügung, sagt aber gleichzeitig, er wolle die beantragte Behandlung versuchen.

22.06.2026

Brief der Kasse erneut gelesen. Gregor sehr angespannt. Kein Spaziergang. Schmerzmittel nach Plan, zusätzlich Wärmekissen. Telefonat mit Sozialdienst: Eilantrag soll vorbereitet werden.

23.06.2026

E-Mail der Klinik mit Termin 01.07.2026 erhalten. Gregor erleichtert, zugleich Sorge wegen Kosten. Schmerz rechte Hüfte 5 bis 8 von 10 über den Tag. Atemnot beim Duschen. Teresa organisiert Duschhocker.

Von	"Prof. Dr. Mira Ebbinghaus" <onkologie@ukm.example.invalid>
An	Gregor Luetke <gregor.luetke@example.invalid>
Datum	Tue, 23 Jun 2026 16:28:52 +0200
Betreff	Termin 01.07.2026 und Unterlagen zur beantragten Therapie

Sehr geehrter Herr L███tke,

wir haben f███r Sie am 01.07.2026 um 08:15 Uhr einen Termin in der onkologischen Tagesklinik reserviert. Der Termin dient zun███chst der klinischen Untersuchung, Laborabnahme und Aufkl███rung. Die Gabe von Lunazimerab kann an diesem Tag nur erfolgen, wenn bis dahin eine belastbare Kostenkl███rung vorliegt.

Medizinisch ist das Zeitfenster eng. Die Bildgebung vom 10.06.2026 zeigt eine zunehmende Belastung der rechten Lunge und eine neue L███sion am Beckenkamm. Ihre Atemnot bei Belastung und die Schmerzspitzen passen dazu. Wir sehen keine kurative Situation. Ziel ist Krankheitskontrolle und Erhalt der Gehstrecke. Das Tumorboard hat wegen Ihrer bisherigen Therapien und der seltenen Tumorbilogie die beantragte Behandlung empfohlen.

Bitte bringen Sie mit:

- aktuellen Medikamentenplan,
- Schmerzprotokoll der letzten sieben Tage,
- Entlassungsbrief der Strahlentherapie aus April 2026,
- Bescheid der Krankenkasse und Schreiben des Medizinischen Dienstes,
- Kontaktdaten einer Vertrauensperson f███r die Aufkl███rung.

Wenn die Finanzierung bis 01.07.2026 offen bleibt, m███ssen wir den Termin in einen Beratungstermin umwandeln. Wir dokumentieren dann, dass die Behandlung nicht aus medizinischen, sondern aus Kostenkl███rungsgr███nden nicht begonnen wurde.

Mit freundlichen Gr███en

Prof. Dr. Mira Ebbinghaus
Ober███rztin Sarkomzentrum
Klinik f███r H███matologie und Onkologie
Universit███tsklinikum M███nster

Datei: 07_therapie_kostenmatrix.csv

dosis	geplanter_tag	kosten_arznei	kosten_ueberwachung	klinisches_ziel	streitpunkt
1	2026-07-11	500000.00	18200.00	initiale Krankheit skontrolle	Eilbeduerftigkeit und Kosten
2	2026-08-22	500000.00	16400.00	Stabilisierung pulmonaler Herde	Nutzenprognose unsicher
3	2026-10-03	500000.00	16400.00	Verlaengerung progressionsfreie Zeit	Folgenabwaegung gegen Wirtschaftlichkeit